长期维持治疗：损伤重→参与修复的肉芽组织多→产生的纤维瘢痕多→瘢痕收缩→食管狭窄

①停药后症状很快**复发**且持续、**重度食管炎（LA-C 和 D 级）**、食管**狭窄**、**Barrett 食管**（下班负重）

破损有融合　癌前病变

②抑酸药中首选 **PPI**

2.弱碱性抗酸药（铝碳酸镁、磷酸铝、硫糖铝、氢氧化铝）：适合轻度患者临时缓解症状

中和胃酸

3.促胃肠动力药（莫沙必利莫剎车）：适合抑酸治疗后疼痛缓解而仍有腹胀的轻度患者

可促进上、下消化道运动→胃肠道压力↓→反流↓ VS 促胃动力药:(吗丁啉/多潘立酮):仅促进上消化道运动

4.腹腔镜胃底折叠术

真题解析·胃食管反流病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N66 A 诊断胃食管反流病，最准确的检查方法是

A.食管吞钡 X 线检查

B.食管测压

C.24 小时食管 pH 监测 金标准

D.胃镜检查

2. 2017N79-81 A 男性，54 岁，近 2 个月来反酸，烧心，多于餐后出现，平卧位时明显，5 天来情况严重，有时伴有胸骨后疼痛，ECG 检查未见明显异常，胃镜检查可见食管黏膜破损融合。LA-C级或D级

79.该患者最可能的诊断是 这里的胸骨后疼痛是刺痛,区别于心绞痛的绞痛

A.胃食管反流病

B.食管憩室炎

C.心绞痛

D.食管癌

80.该患者最佳的治疗方法是

A.氢氧化铝

B.硝酸甘油

C.奥美拉唑

D.尽早手术

81.若维持治疗，选用的最佳药物为

下班负重→维持治疗

A.雷尼替丁

B.奥美拉唑

C.硝酸异山梨酯

D.顺铂和 5-氟尿嘧啶

题目:胃镜下没有看到食管黏膜破损不能排除胃食管反流病,因为有两个类型(RE和NERD),先做食管反流检测→明确是否存在反流的客观证据→结合PPI试验性治疗有效→诊断NERD

3. 2019N50 A 下列引起胃食管反流病的病因中，不属于抗反流屏障结构与功能异常的是

A.胃扩张 胃压力高,抵着LES

B.贲门失弛缓症手术后 破坏LES

C.大量腹水 抵着LES

D.干燥综合征食管清除作用↓

答案:1-3 C ACB D